

QUADRIL DO IDOSO — OPERAR EM ATÉ 48H

CLASSIFICAÇÃO E TRATAMENTO

Tipo	Localização	Tratamento usual
Colo do fêmur (intracapsular)	Entre cabeça e trocânteres	Desviada: artroplastia (risco de necrose avascular)
Colo sem desvio / jovem	Intracapsular	Fixação interna (parafusos) se viável
Transtrocantérica (extracapsular)	Entre os trocânteres	Fixação: haste cefalomedular ou DHS
Subtrocantérica	Abaixo dos trocânteres	Haste intramedular
Clínica	Dor + encurtamento + rotação externa do membro	Membro encurtado e rodado externamente
Imagem	Radiografia (AP de bacia + perfil); RM/TC se oculta	Fratura oculta: RM se dor persistente e RX normal

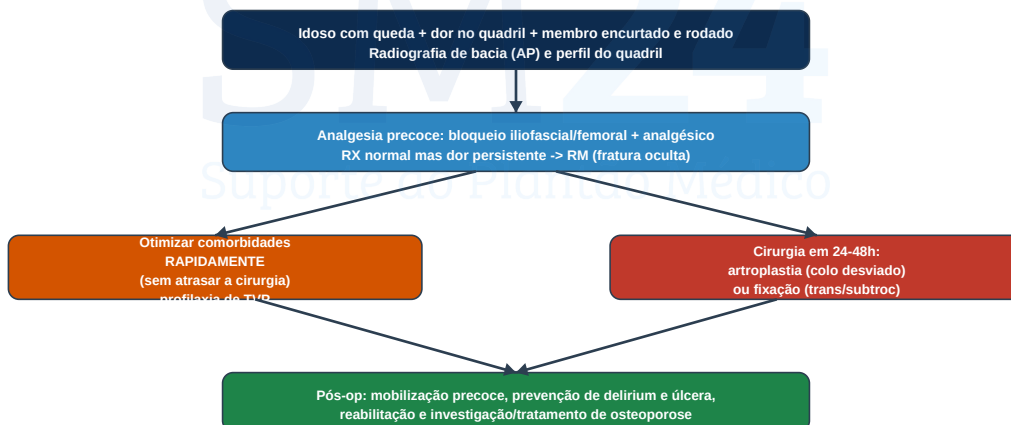
CIRURGIA PRECOCE SALVA VIDAS

OPERAR EM ATÉ 24-48H REDUZ MORTALIDADE E COMPLICAÇÕES

- A cirurgia precoce (idealmente em 24-48h) reduz mortalidade, delirium, TVP, úlcera de pressão e tempo de internação
- Não atrasar a cirurgia por exames desnecessários — otimizar rapidamente as comorbidades
- Analgesia eficaz desde a admissão: bloqueio do nervo femoral / iliofascial é muito eficaz e reduz opioides
- Mobilização precoce no pós-operatório (sentar/andar) previne complicações do imobilismo
- A fratura de quadril no idoso tem alta mortalidade em 1 ano — é um marcador de fragilidade
- Abordagem multidisciplinar (ortogeriatría) melhora desfechos

ABORDAGEM NO PS

QUADRIL — ANALGESIA + OTIMIZAR + OPERAR



PREVENÇÃO DE COMPLICAÇÕES

Complicação	Prevenção
Tromboembolismo (TVP/TEP)	Profilaxia com HBPM + mobilização precoce
Delirium	Cirurgia/analgesia precoces, evitar BZD, reorientação, sono, hidratação
Úlcera de pressão	Mobilização, mudança de decúbito, colchão adequado
Infecção respiratória/urinária	Mobilização, retirar sondas precocemente, fisioterapia
Anemia/descompensação	Avaliar transfusão e otimizar comorbidades sem atrasar a cirurgia
Nova fratura	Tratar osteoporose (cálcio, vitamina D, bifosfonato) e prevenir quedas

ANALGESIA E ORTOGERIATRIA

Analgesia no PS

- Bloqueio do nervo femoral ou iliofascial: muito eficaz, reduz a necessidade de opioides
- Analgesia multimodal: dipirona/paracetamol + opioide titulado
- Cuidado com opioides em altas doses no idoso (delirium, depressão respiratória)
- Evitar AINE em idoso frágil/nefropata
- Imobilização e posicionamento confortável
- Reavaliar a dor com escala apropriada

Cuidado Multidisciplinar

- Orto geriatria: ortopedia + geriatria + anestesia + fisioterapia
- Avaliação rápida de comorbidades para liberar a cirurgia
- Plano de reabilitação desde a admissão
- Avaliar causa da queda (síncope, arritmia, hipotensão, medicações)
- Prevenção secundária de quedas e tratamento da osteoporose
- Suporte nutricional e cognitivo

CONDUTA NO PS

PONTOS-CHAVE

- ☐ Reconhecer: idoso com queda + dor no quadril + membro encurtado e rodado externamente
- ☐ Radiografia (AP de bacia + perfil); RM se RX normal com dor persistente (fratura oculta)
- ☐ Analgesia precoce com bloqueio iliofascial/femoral + multimodal
- ☐ Otimizar comorbidades rapidamente, SEM atrasar a cirurgia
- ☐ Cirurgia em 24-48h (artroplastia no colo desviado; fixação nas extracapsulares)
- ☐ Profilaxia de TVP, prevenção de delirium/úlcera, mobilização precoce e tratamento da osteoporose

Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Idosa de 82 anos com fratura de quadril após queda. Qual conduta reduz a mortalidade e as complicações?

- A) Tratamento conservador com repouso prolongado no leito
- B) Cirurgia precoce (em 24-48h), com analgesia e otimização rápida das comorbidades
- C) Aguardar 2 semanas para operar
- D) Imobilização gessada
- E) Tração cutânea por tempo indefinido

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Paciente com fratura desviada do colo do fêmur. Qual o tratamento usual e por quê?

- A) Fixação com parafusos sempre
- B) Artroplastia, pelo alto risco de necrose avascular da cabeça femoral
- C) Tratamento conservador
- D) Apenas fisioterapia
- E) Haste intramedular

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Qual técnica de analgesia é muito eficaz e reduz o uso de opioides na fratura de quadril?

- A) AINE em alta dose
- B) Bloqueio do nervo femoral ou iliofascial
- C) Apenas paracetamol oral
- D) Sedação profunda
- E) Corticoide IV

QUESTÃO 4

SES-SP / Adaptada

Idoso com queda e dor no quadril, radiografia inicial normal, mas com dor persistente e incapacidade de deambular. Qual a conduta?

- A) Alta com analgésico
- B) RM do quadril para investigar fratura oculta
- C) Repetir a mesma radiografia em 30 dias
- D) Imobilização e observação domiciliar
- E) Cintilografia imediata como primeira escolha

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Além do tratamento cirúrgico, qual medida é fundamental na prevenção secundária após fratura de quadril por fragilidade?

- A) Restringir a deambulação permanentemente
- B) Tratar a osteoporose (cálcio, vitamina D, bifosfonato) e prevenir novas quedas
- C) Suspender toda atividade física
- D) Iniciar anticoagulação oral por toda a vida
- E) Repouso absoluto no leito

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A cirurgia precoce (em 24-48h), com analgesia eficaz e otimização rápida das comorbidades, reduz mortalidade, delirium, TVP, úlcera de pressão e tempo de internação. O tratamento conservador com imobilismo prolongado aumenta as complicações.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A fratura desviada do colo do fêmur (intracapsular) compromete a vascularização da cabeça femoral, com alto risco de necrose avascular e pseudoartrose. Por isso, no idoso, o tratamento usual é a artroplastia (substituição), e não a fixação.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

O bloqueio do nervo femoral ou iliofascial é uma técnica de analgesia muito eficaz na fratura de quadril, reduzindo a dor e a necessidade de opioides — o que diminui o risco de delirium e depressão respiratória no idoso.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Dor persistente e incapacidade de deambular após queda, com radiografia normal, levantam a suspeita de fratura oculta. A RM do quadril é o exame de escolha para detectá-la (mais sensível que a radiografia e a TC).

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A fratura de quadril por fragilidade indica osteoporose. A prevenção secundária inclui tratar a osteoporose (cálcio, vitamina D, bifosfonato/outras) e prevenir novas quedas — fundamental para evitar nova fratura.

SM24
Suporte ao Plantão Médico